

MEMENTO RESUMIDO — Saúde Mental e Qualidade de Vida

CFO PM 2026 · Revisão por módulos

MÓD. 1 — CONCEITOS: SAÚDE MENTAL, QV E QVT

- **Saúde Mental (OMS):** estado de **bem-estar** em que a pessoa **reconhece suas habilidades**, lida com o **estresse normal** da vida, trabalha produtivamente e contribui para a comunidade. <mark>NÃO é apenas a ausência de doença</mark> — é equilíbrio **emocional, psicológico e social**.
- **Qualidade de Vida (OMS):** "percepção do indivíduo sobre sua posição na vida, no contexto da cultura e dos valores, em relação a objetivos, expectativas, padrões e preocupações". Conceito **dinâmico, contingencial e multidisciplinar**.
- **Inter-relação:** boa saúde mental → percepção mais positiva de QV; problemas de saúde mental **reduzem** a QV (trabalho, relações, satisfação).
- **QVT (Qualidade de Vida no Trabalho):** termo cunhado por **Louis Davis (década de 1970)**, em projeto de **desenho de cargos**. Integra aspectos **físicos/ambientais + psicológicos**; concilia o **bem-estar do colaborador** com a **produtividade** da organização (Chiavenato).

△ Saúde mental ≠ só "ausência de doença" — é estado positivo de bem-estar (OMS). QVT = **Louis Davis (1970)**.

MÓD. 2 — FATORES QUE IMPACTAM A SAÚDE MENTAL E A QV

- **Ambiente de trabalho:** estresse, **pressão por resultados**, falta de apoio social e condições físicas afetam a saúde mental — com reflexo direto na **produtividade**.
- **Profissão policial:** exposição contínua a **risco, violência, escala/plantão, cobrança social e hierárquica** eleva a vulnerabilidade.
- Fatores **individuais** (histórico, personalidade, suporte familiar) e **coletivos/sociais** (cultura, condições socioeconômicas) interagem.
- A promoção da saúde mental no trabalho exige **ambiente positivo, comunicação clara, reconhecimento e programas de apoio**.

MÓD. 3 — TRANSTORNOS MAIS COMUNS NA SEGURANÇA PÚBLICA

Estresse

- **Marilda Lipp:** reação **psicofisiológica** complexa diante de algo que ameaça a **homeostase** (equilíbrio interno).
- **Fontes:** eventos de vida, problemas cotidianos, estresse ambiental (ruído, lotação), do trabalho (sobrecarga, esgotamento) e socioculturais.
- **4 fases (Lipp):** alerta → **resistência** → **quase-exaustão** → **exaustão**. O estresse **crônico** aumenta a vulnerabilidade a doenças (cardíacas, hipertensão).

Síndrome de Burnout

- **Esgotamento profissional:** exaustão extrema por trabalho desgastante; **causa principal = excesso de trabalho**. Comum em quem atua sob pressão (policiais, médicos, professores).
- Pode evoluir para **depressão profunda** — buscar apoio nos **primeiros sintomas**.

Depressão

- **Tristeza constante e prolongada:** doença **psiquiátrica crônica** e recorrente. Prevalência ao longo da vida no Brasil ~**15,5%**; OMS a coloca em **4º lugar** entre causas de ônus (1º em tempo vivido com incapacidade). **Aumentada** entre profissionais de segurança.

Transtorno Bipolar

- Alterações de humor com **oscilação entre euforia (mania) e depressão**. **Hipomania** (mania leve) pode ser **sinal precoce**. Início na adolescência/início da vida adulta.

Transtornos de Ansiedade

- Ansiedade é **reação normal** a ameaça; torna-se transtorno quando **intensa/frequente** e incapacitante.

- Tipos: **TAG** (generalizada), **Transtorno de Pânico**, **fobia social**, **agorafobia** e **TEPT** (estresse pós-traumático).

△ Pelo **DSM-5**, o **TOC** NÃO está mais na categoria dos transtornos de ansiedade (passou a categoria própria — "TOC e transtornos relacionados"). △ **Estresse × Burnout:** o burnout é **específico do trabalho** e pode evoluir para depressão; o estresse comum é mais amplo. **TEPT** liga-se a evento **traumático**.

MÓD. 4 — ESTIGMAS E BUSCA DE AJUDA

- **Estigma:** preconceito que associa o transtorno mental à **fraqueza/incapacidade** — leva o profissional a **esconder o sofrimento** e adiar a ajuda (medo de retaliação, de ser afastado, de "perder a farda").
- Na cultura policial (força, controle), o estigma é **reforçado** — daí a importância de **normalizar** a busca por ajuda.
- **Buscar ajuda é sinal de força e autocuidado**, não de fraqueza; o sigilo profissional protege quem procura apoio.

△ O estigma é a **principal barreira** à procura de ajuda em saúde mental entre policiais.

MÓD. 5 — VITIMIZAÇÃO POLICIAL

- **Vitimização:** processo pelo qual o policial **torna-se vítima** — física ou psicologicamente — em razão da atividade.
- **Primária:** dano direto do evento criminoso/violento (lesão, trauma da ocorrência).
- **Secundária (revitimização):** sofrimento causado pela **resposta inadequada** das instituições e da sociedade (descaso, exposição, burocracia, falta de apoio).
- **Terciária:** efeitos prolongados sobre o policial e seu **entorno** (família, colegas).

△ A **vitimização secundária** decorre da própria instituição/sistema — não do crime em si.

MÓD. 6 — RECURSOS DE APOIO NA PMPE

- **Núcleo de Saúde Mental "Ten Cel PM Aline Maria Lopes dos Prazeres":** serviço de acolhimento e atendimento psicológico aos militares.
- **FCAS — Fundação de Apoio ao CAS** (Centro de Apoio Social): apoio assistencial e psicossocial.
- **Projeto Escuta SUSP** (Ministério da Justiça e Segurança Pública): canal de **escuta/apoio psicológico** aos profissionais de segurança.
- **Promoção e prevenção:** programas de QVT, rodas de conversa, capacitação de líderes para identificar sinais e **encaminhar** (atuação preventiva, não só curativa).

△ O papel do oficial-líder é **identificar sinais precoces e encaminhar o subordinado aos serviços** — não diagnosticar nem tratar.